EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 79252
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-02-19 12:48:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: HORTENSIA DEL C VERA CARO			RUN	: 8.497.965-1
F.Nac	: 20-01-1956	Edad	: 68 AÑOS	Género	: Femenino
Dirección	: PUYAMAVIDA TORRECILLAS ACT			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA A	Teléfono	: 85279446		
Fecha Ingreso	: 2024-02-13	Fecha Egreso	: 2024-02-19 12:48:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. L03.1-CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIENBROS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) Celulitis EID en tratamiento
2) IC con FEVI 40%
3) DM2
4) Obesidad
5) Asma
6) DLP
7) Obesidad
8) AC x FA en TACO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. L03-CELULITIS (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente consulta en SU el dia 13/02 por cuadro de algia abdominal epigastrica, nauseas, vomitos desde ese mismo dia, sin deposiciones diarreicas, sin peak febril, sin antec de transgresion alimentariaal examen fisico se evidencia coloracion violacea e induracion en EEII derecha en region psoterior.
Examenes de lab destaca PCR al ingreso de 48,5, se ingresa para terapia ATB
Durante estadia se inicia terapia ATB con terapia ATB con cloxacilina, se forma psoterior se asocia penicilia, con disminucion de parametros inflamatorios

Paciente HDN estable, afebril, sin dolor al interrogatorio dirigido, con buena tolerancia a alimentacion oral, diuresis y deposiciones (+), con disminucion de eritema en zona afectada acorde a relato de paciente. Cultivo del 15/02 sin desarrollo bacteriano
AngioTAC miembros inferiores del 16/02 con incremento de la densidad y espesor de las partes blandas pretibiales en el sector distal pretibial derecho, sin evidencia de colecciones, sin signos

de trombosis, signos de ateromatosis parietal calcificada difusa del arbol vascular, sin signos de estenosis

Examenes de lab 19/02 -> crea 0,8; PCR 32,7; Na/K/Cl 136/3.3/104; Gb 5; Hb/Hcto 11.9/35.6; plaq 160000; segment 42%; proca 0.26

CSV 10:48 hrs 19/02-> Fc 63; T° ax 36,4°C; P/A 143/88; PAM 109; FR 20; Sat O2 91% FiO2 21%

Ex fisico -> Vigil, CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Extremidades se aprecia eritema e induracion en tercio inferior posterior de EID, con aumento de T° local

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso: Resultado de cultivos negativos, se procedera a traslape ATB a via oral, para completar 10 dias de terapia ATB total, continuar con curaciones dia por medio de zona afectada, se solicitaran examenes de control dia 23/02. En condiciones de continuar seguimiento de paciente via HODOm
4) Hematologico: Debido a inicio de anticoagulacion a dosis plena con enoxaparina
5) TMT: ACtualmente en seguimiento por TMT por Fx de radio distal derecho, debe continuar con seguimiento de caracter ambulatorio

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Regimen dibetico hiposodico a tolerancia
3. Cefadroxilo 500 mg c/12 hrs VO por 6 dias
4. Dabigatran 150 mg c/12 hrs VO
5. Furosemida 40 mg al dia VO
6. Espironolactona 25 mg al dia VO
7. Carvedilol 6,25 mg, medio comp c/12 hrs VO
8. Bromuro de ipratropio 4 puff c/6hrs por AC
9. Fluticasona/Salmeterol 2 puff c/12 hrs por AC
10. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/12 hrs VO SOS por 6 dias
11. Examenes de control 23/02
12. Continuar con seguimiento ambulatorio por parte de TMT
13. Curaciones a realizar dia por medio

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO